

PROYECTO BADBEAR.MED | MASTERCLASS QUIRÚRGICA

ABDOMEN AGUDO QUIRÚRGICO: INFLAMATORIO Y OBSTRUCTIVO

Abordaje Integral, Radiología Intervencionista,
Control del Foco y Esquemas Antibióticos.



FISIOPATOLOGÍA: DE LA INFLAMACIÓN A LA SEPSIS



Agresión Local

- Lesión tisular → Liberación de mediadores → Aumento de permeabilidad vascular.



Edema y Exudado

- Proliferación bacteriana → Formación de pus → Isquemia parietal.



Necrosis y Perforación

- Ruptura estructural → Derrame de contenido purulento/fecaloideo a la cavidad.



Peritonitis

- Inflamación localizada o generalizada del peritoneo.



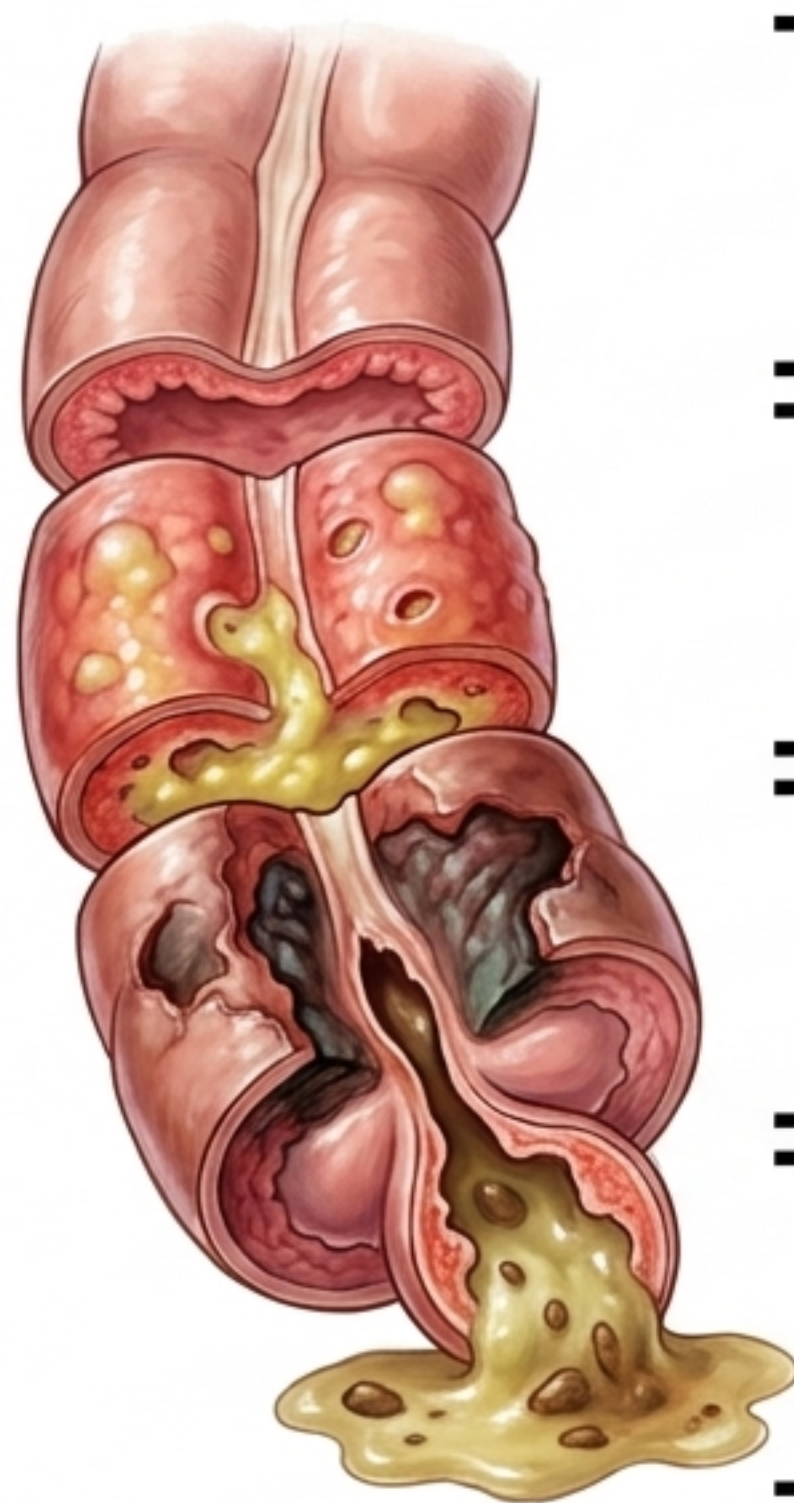
Choque Séptico

- Respuesta sistémica (SIRS) → Falla Multiorgánica → Muerte.

OBJETIVO QUIRÚRGICO:
Interrumpir esta cascada antes de la fase sistémica.



PROGRESIÓN CLÍNICA: EL MODELO DE LA APENDICITIS



Catarral: Inflamación mucosa incipiente.

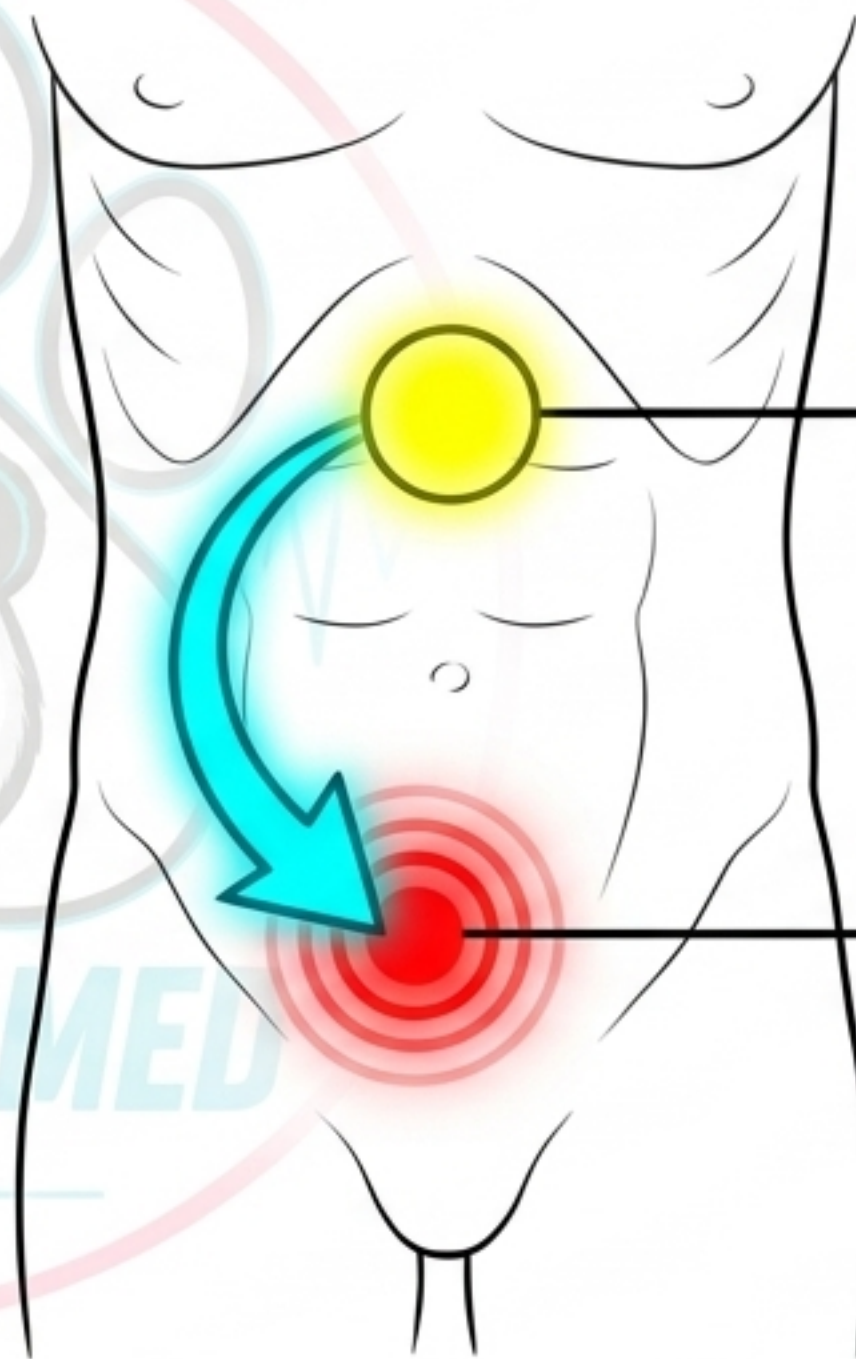
Flegmonosa: Úlceras, exudado purulento.

Gangrenosa: Isquemia y necrosis parietal.

Perforada: Derrame y peritonitis.

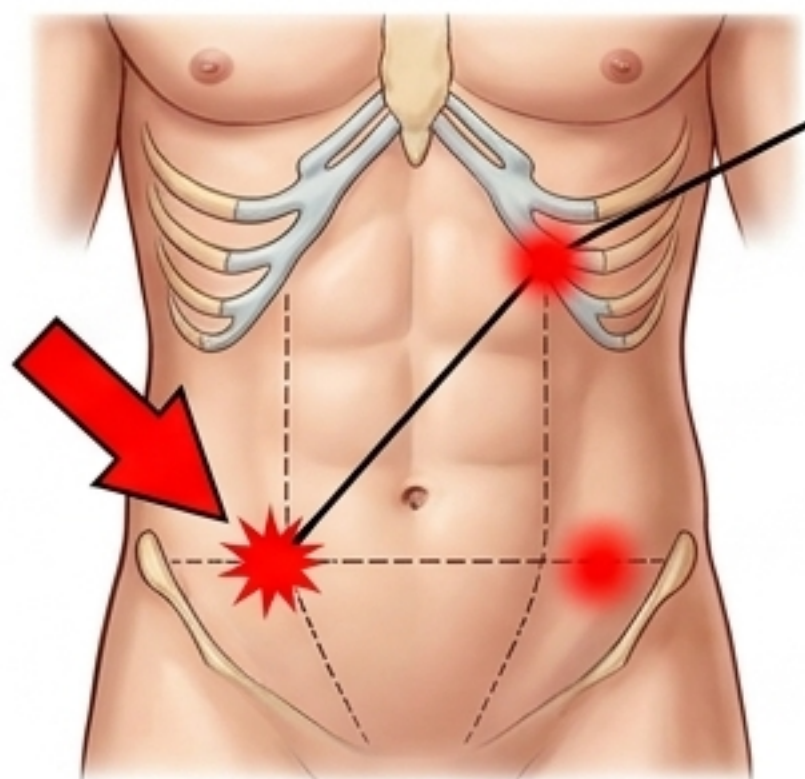
Fase Visceral (Prodrómica): Dolor sordo, periumbilical (T10), síntomas vagos (náuseas).
Causa: Distensión visceral.

Fase Somática (Parietal): Dolor agudo, localizado en Fosa Iliaca Derecha.
Causa: Irritación del peritoneo parietal.



SEMIOLOGÍA Y CUADROS ATÍPICOS (TRAMPAS DIAGNÓSTICAS)

Signos Clave de Irritación Focal:

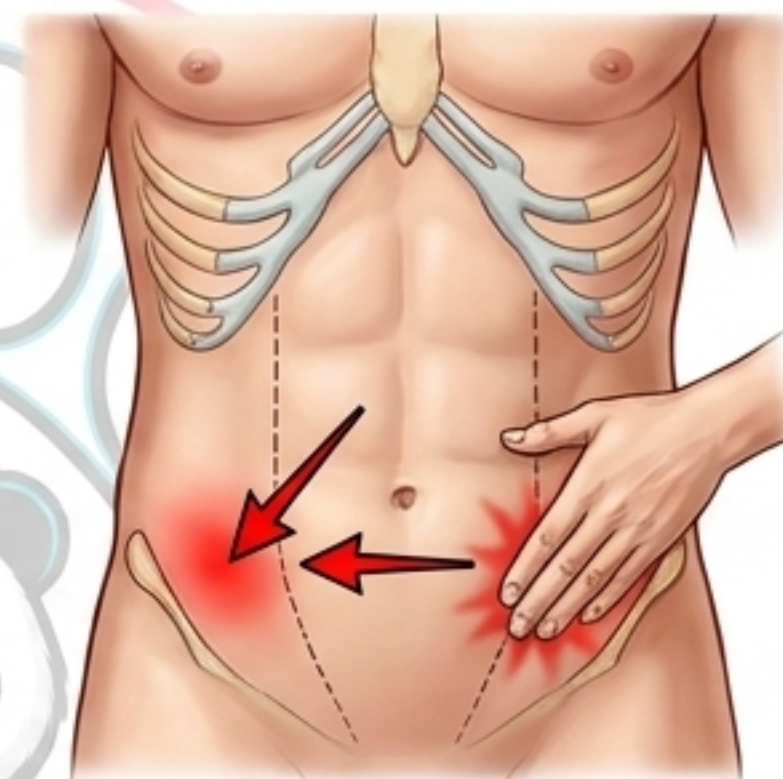


- **McBurney:** Dolor máximo (unión 1/3 externo con 2/3 internos).



- **Blumberg (Rebote):** Dolor a la descompresión brusca.

Signos de Reflexión y Difusión:



- **Rovsing:** Presión en FII causa dolor en FID (desplazamiento de gas).



- **Guéneau de Mussy:** Abdomen en tabla (peritonitis difusa).

Trampas Demográficas:



- **Obesidad Mórbida:** Ciego de implantación alta; simula dolor vesicular o cólico renal.
- **Gestantes:** El crecimiento uterino desplaza el ciego y altera la topografía clásica del dolor.

Trampas Clínicas:

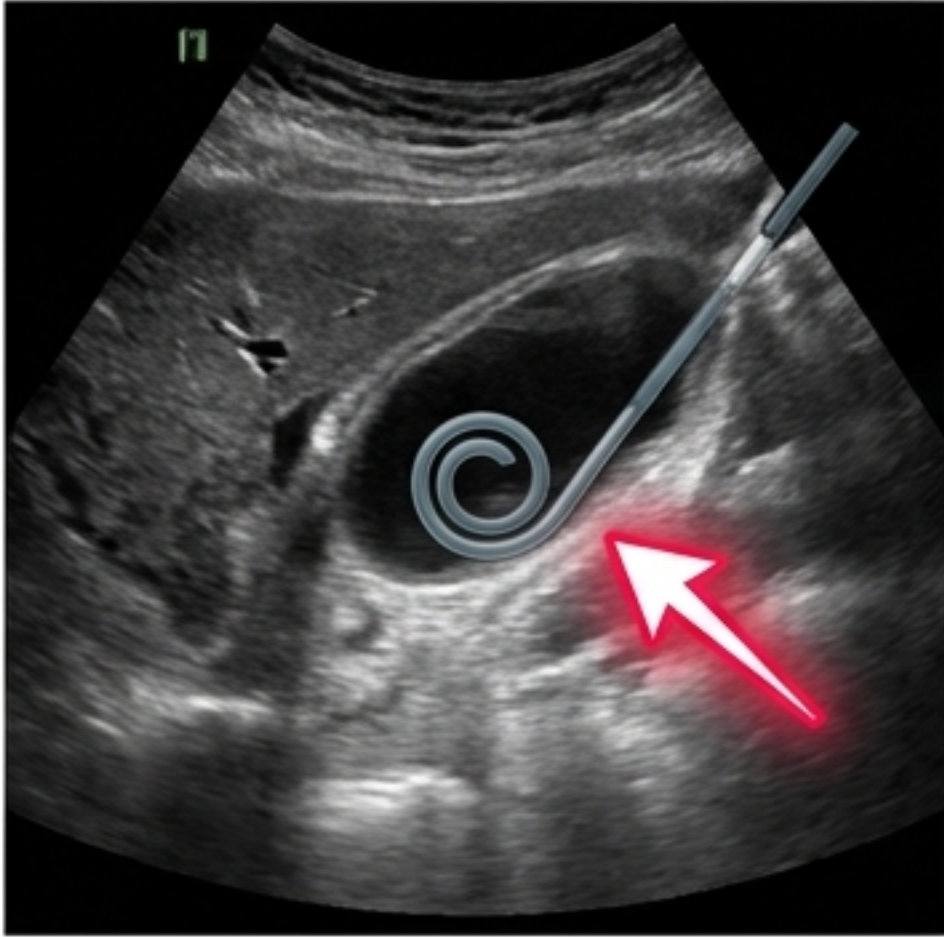
- **Simulación de GECA:** Frecuente debut actual como diarrea/enterocolitis que retrasa el diagnóstico letalmente.
- **Ancianos:** Clínica sorda, sin fiebre evidente; frecuentemente simula una impactación fecal.



RESCATE MÍNIMAMENTE INVASIVO: RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

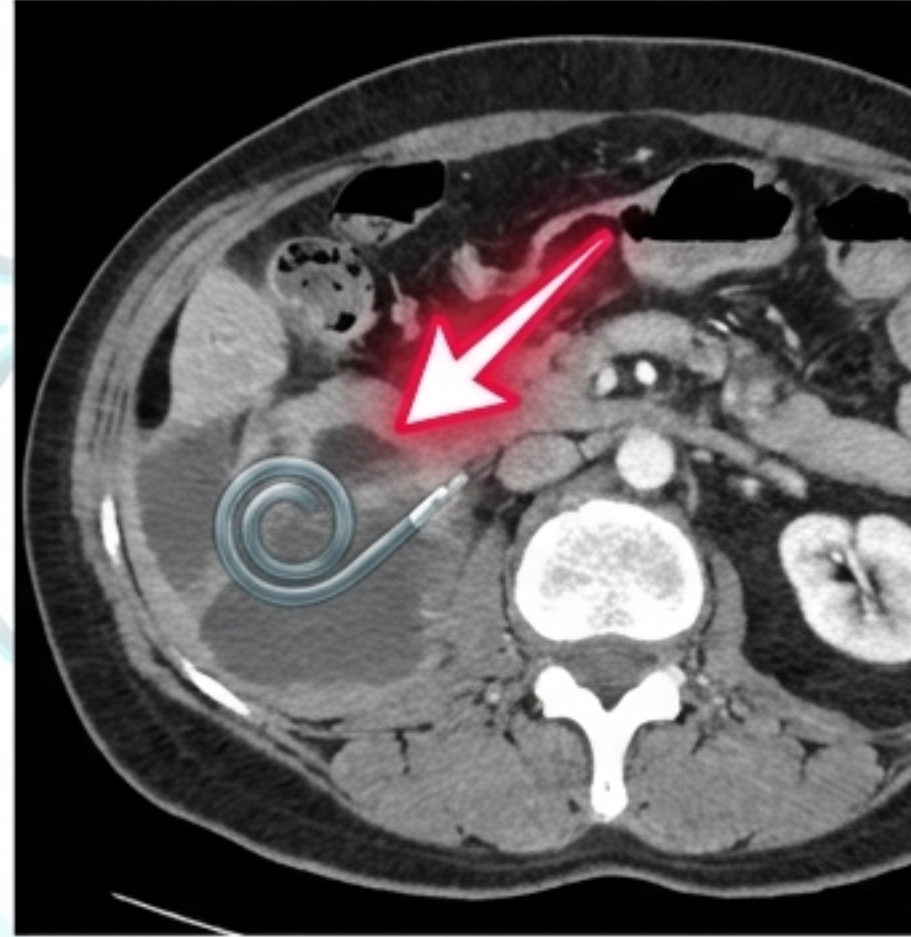
Concepto: Evita cirugía abierta urgente en pacientes sépticos o con alto riesgo anestésico y tejidos friables.

1. Piocolecisto (Vesícula)



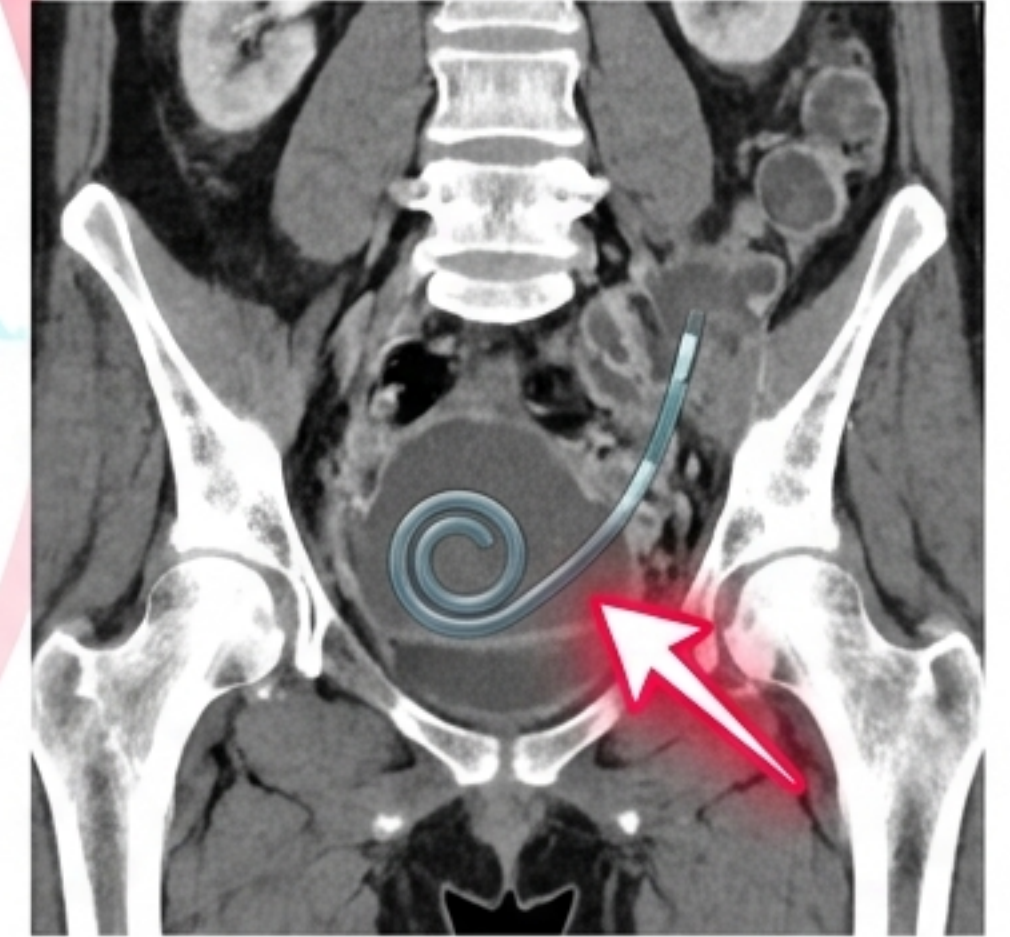
Colecistostomía percutánea guiada por imagen. Descomprime el pus; permite colecistectomía electiva tras enfriamiento.

2. Plastrón/Absceso Apendicular



Drenaje percutáneo (colecciones >3-5 cm) + Antibióticos. Evita lesión iatrogénica del ciego.

3. Diverticulitis (Hinchey II)



Drenaje de macroperforación pélvica contenida. Evita Ostomía de Hartmann de urgencia.



ABDOMEN OBSTRUCTIVO: ÍLEO MECÁNICO VS. PARALÍTICO



ÍLEO MECÁNICO (Falla Física)

- Naturaleza: **Obstáculo anatómico** real.
- Auscultación: **Peristaltismo de lucha** (ruidos metálicos iniciales).
- Causas Intestino Delgado: **Bridas/Adherencias** (60-70%) - Inevitable cicatrización post-cirugía, **Hernias encarceladas** (15-20%).
- Causas Colon: **Cáncer colorrectal** (60%), **Vólvulo de sigmoides** (20-30%).



ÍLEO PARALÍTICO (Falla Funcional)

- Íleo Paralítico (Falla **Funcional**).
- Naturaleza: **Falla motora** sin oclusión demostrable.
- Auscultación: **Silencio** abdominal desde el inicio.
- Causas: Postoperatorio fisiológico, **Hipopotasemia** severa, **Opioides**, Peritonitis química.



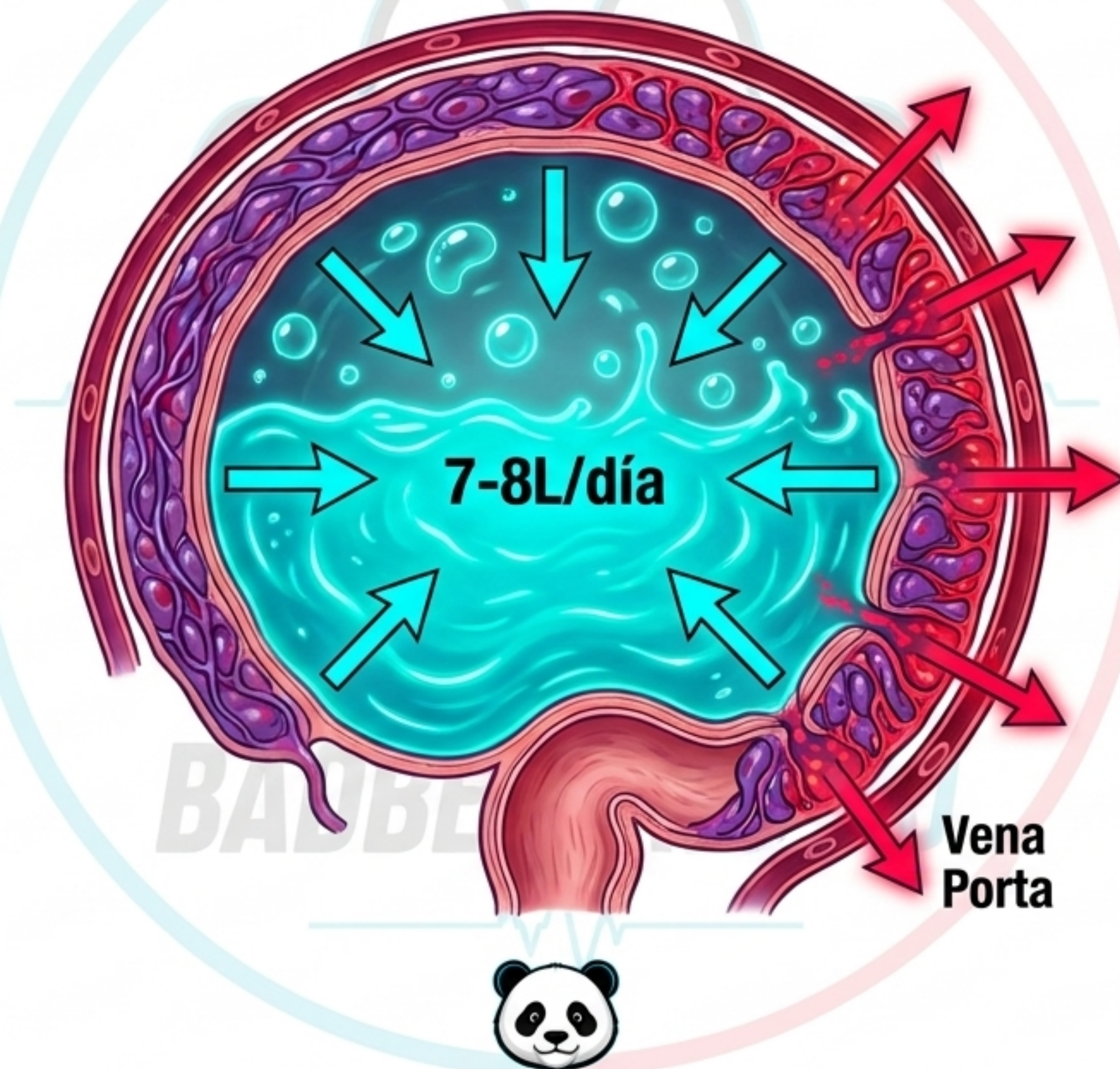
LA PRESIÓN LETAL: TERCER ESPACIO E ISQUEMIA

1. Distensión Luminal:

Acumulación masiva de secreciones diarias (saliva, bilis, jugo gástrico) + gas bacteriano.

3. Secuestro (Tercer Espacio):

Extravasación masiva de plasma a la luz y peritoneo → Shock hipovolémico severo e IRA.



2. Ley de Laplace:

A mayor diámetro del asa intestinal, mayor será la tensión parietal destructiva.

4. Isquemia y Translocación:

Colapso microvascular → Pérdida de uniones estrechas → Translocación de *E. coli* y *B. fragilis* a vena porta → **SHOCK SÉPTICO.**

TOPOGRAFÍA DE LA OBSTRUCCIÓN: EL ESPECTRO DEL VÓMITO

Obstrucción Alta - Intestino Delgado

EL VÓMITO
PORRÁCEO

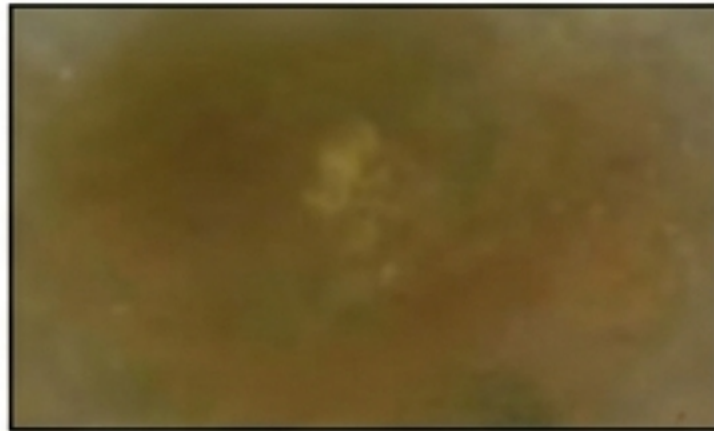


Verde Puerro/Pasto

- **Clínica:** Vómitos precoces y abundantes. Distensión central.
- **Laboratorio:** **Alcalosis metabólica hipoclorémica e hipopotasémica.**
- **Naturaleza:** Aspecto verde pasto oscuro. Mezcla de **bilis** y **jugos digestivos superiores.**

Obstrucción Baja - Colon

EL VÓMITO
FECALOIDE



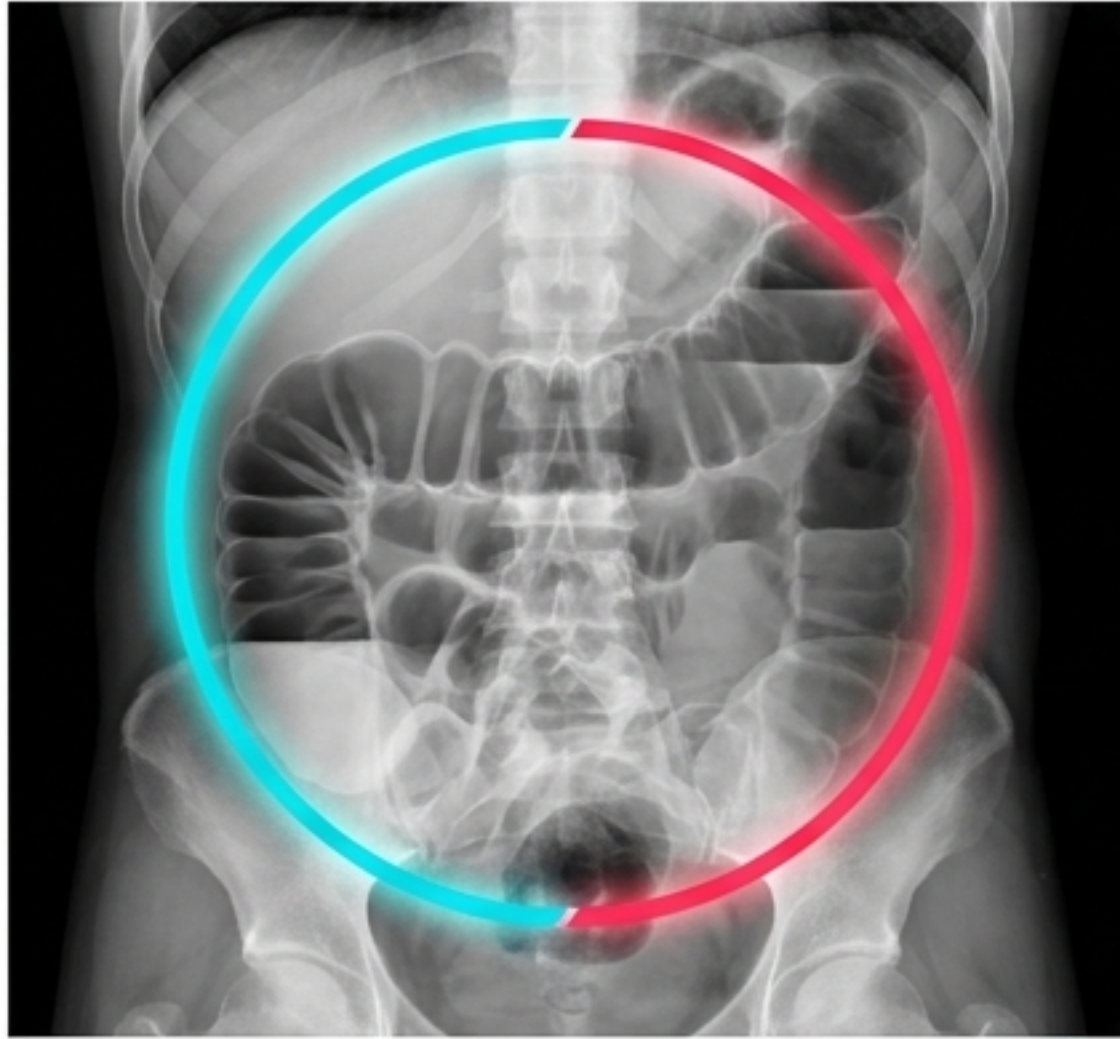
Marrón Chicha de Jora

- **Clínica:** Vómitos tardíos. Distensión periférica masiva.
- **Laboratorio:** **Acidosis metabólica (Anion Gap elevado) + Hiperlactatemia por isquemia.**
- **Naturaleza:** Aspecto marrón/turbio, **olor francamente fecal. Signo tardío y de catástrofe inminente.**



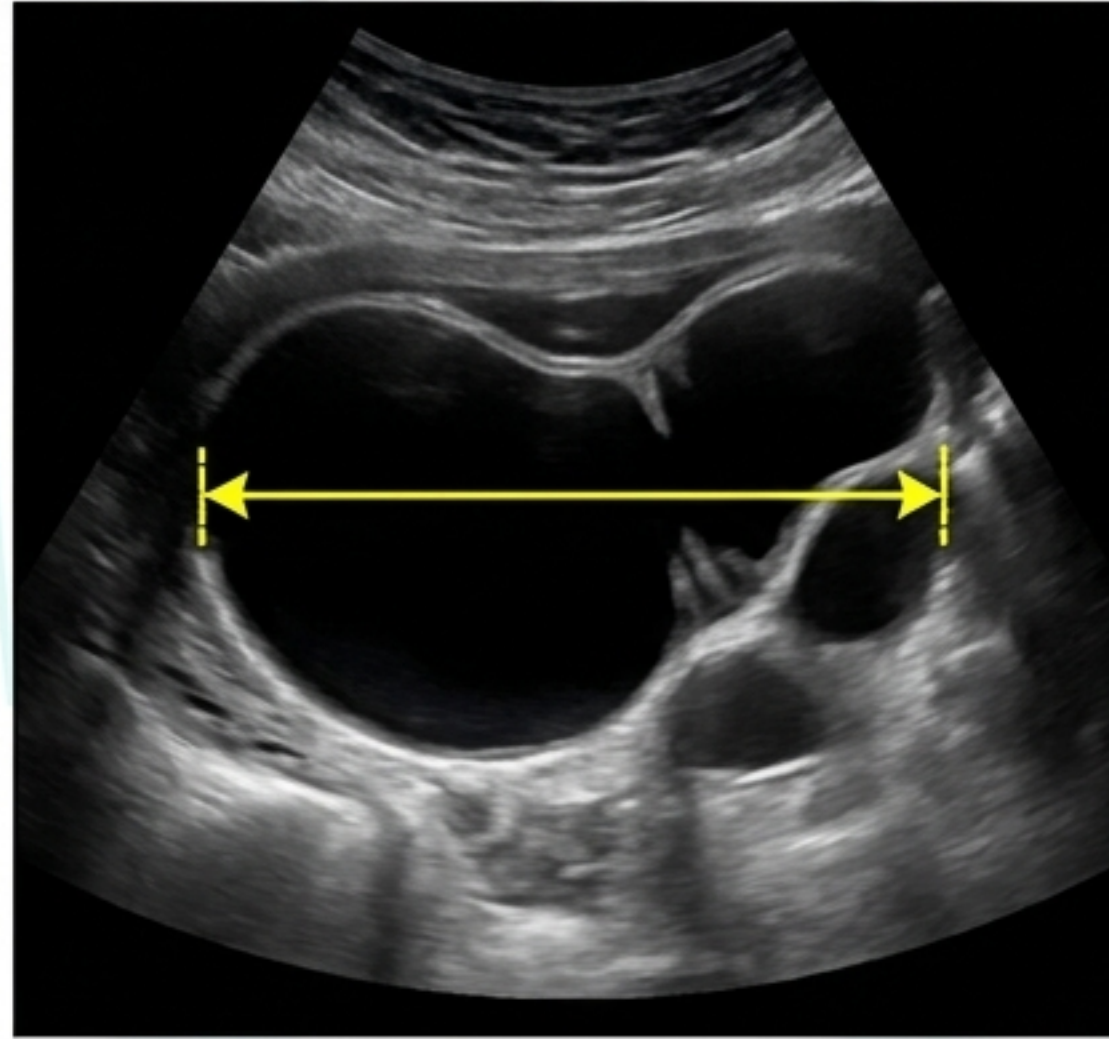
RADIOLOGÍA OBSTRUCTIVA: SIGNOS INEQUÍVOCOS

Radiografía Simple



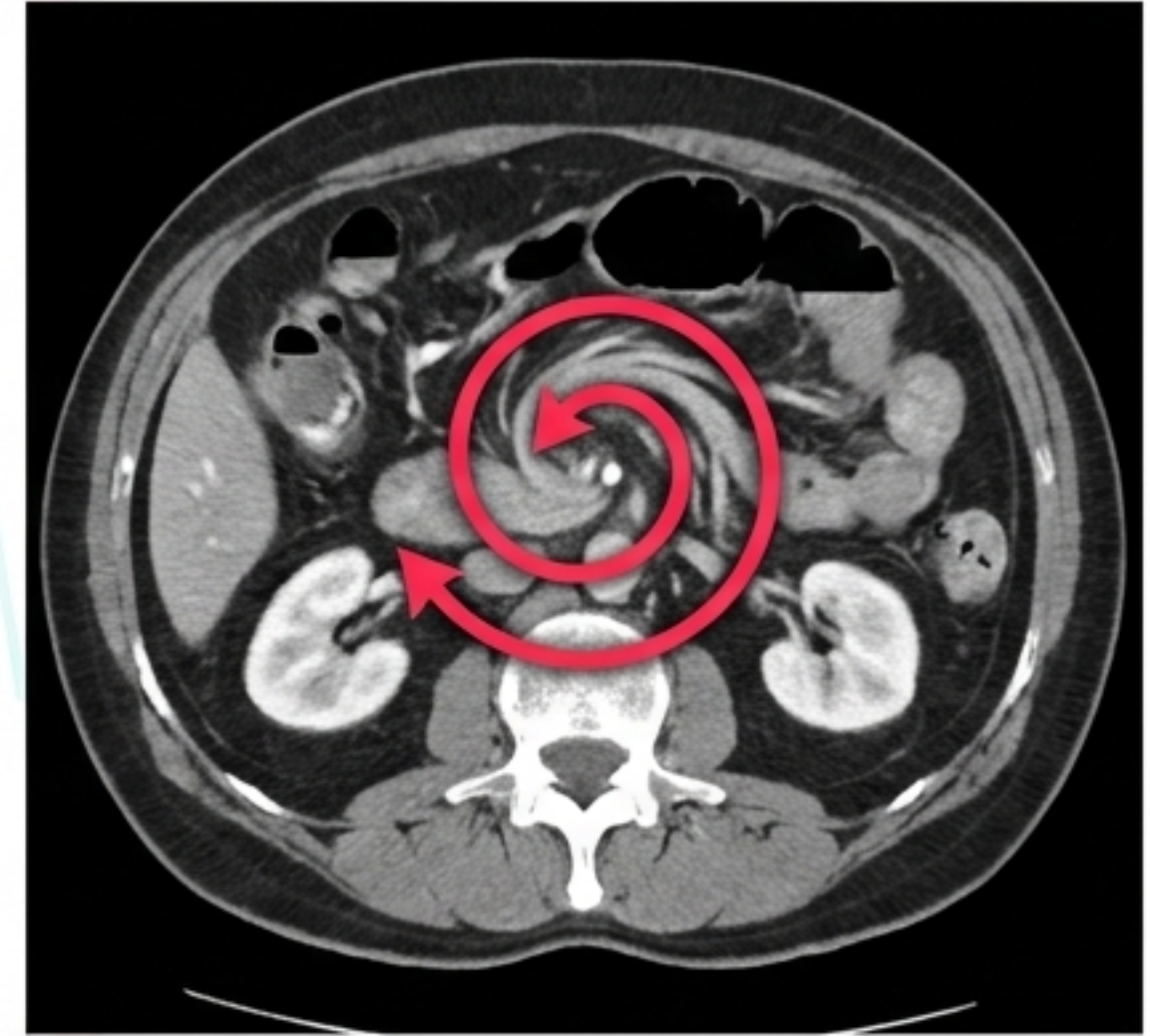
- Signo de la **Pila de monedas** (edema de válvulas conniventes).
- **Niveles en escalera** (>2.5 cm).
- **Grano de café** (Vólvulo).

Ecografía (POCUS a pie de cama)



- Criterios críticos de dilatación: Intestino Delgado >3 cm | Colon >6 cm | Ciego >9 cm.
- Presencia de líquido libre anecoico.

Tomografía con Contraste (Gold Standard)



- Sensibilidad >95%.
- Identifica la zona de transición y el **Signo del remolino** (vólvulo).
- Isquemia: Neumatosis intestinal o gas portal.



ALGORITMO DE MANEJO: DESCOMPRESIÓN Y DECISIÓN

Paso Cero: LA DESCOMPRESIÓN

Vital para aliviar tensión y evitar neumonía aspirativa.

Sonda Nasogástrica gruesa (18 French) + Sonda Rectal (en vólvulo incipiente) +
Resucitación hídrica.

Bridas y Adherencias

Manejo conservador inicial.
Si el contraste no avanza tras
24-48h o hay signos de
isquemia → Quirófano.

Hernia Encarcelada

Intento de reducción manual
→ Si falla o hay signos de
estrangulación → Cirugía de
urgencia (Hernioplastia).

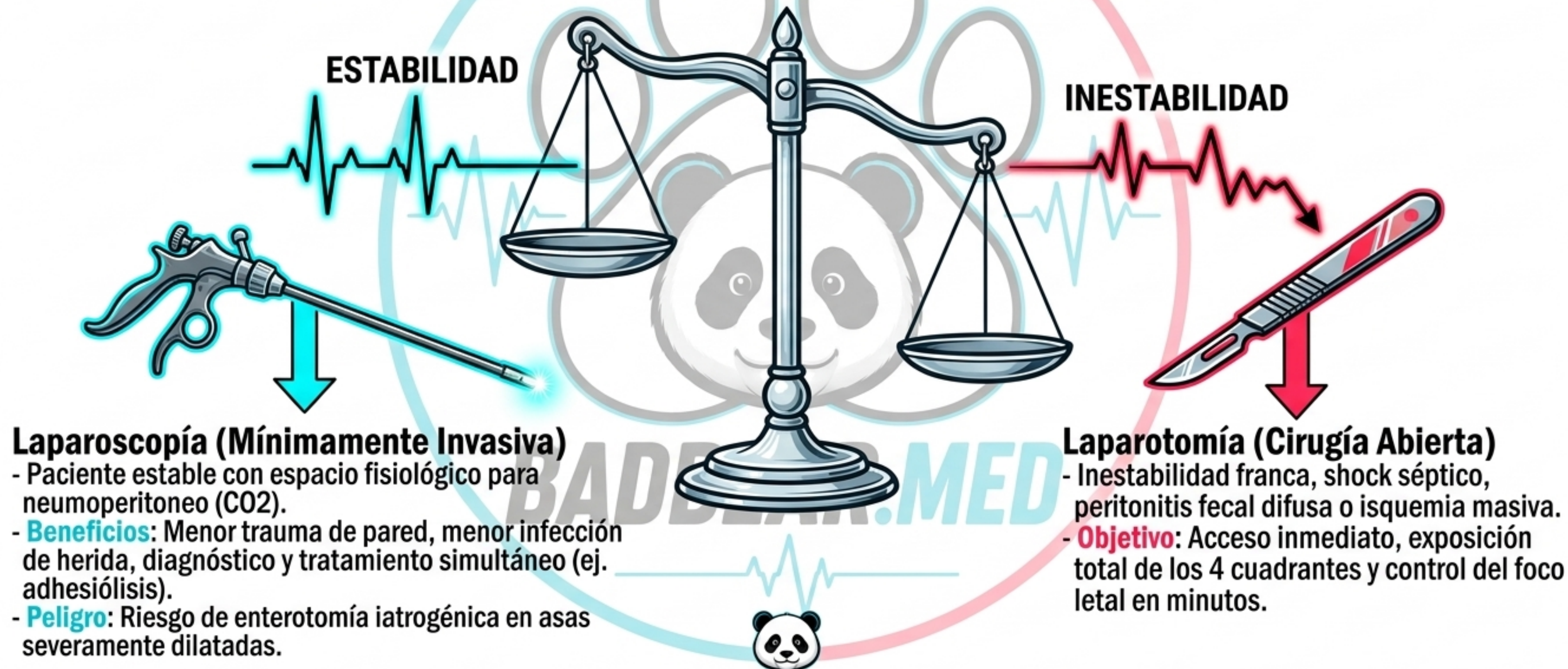
Vólvulo Sigmoides con Necrosis

Fracaso de devolvulación
endoscópica → Operación de
Hartmann (Resección +
Colostomía terminal + Cierre
de muñón).



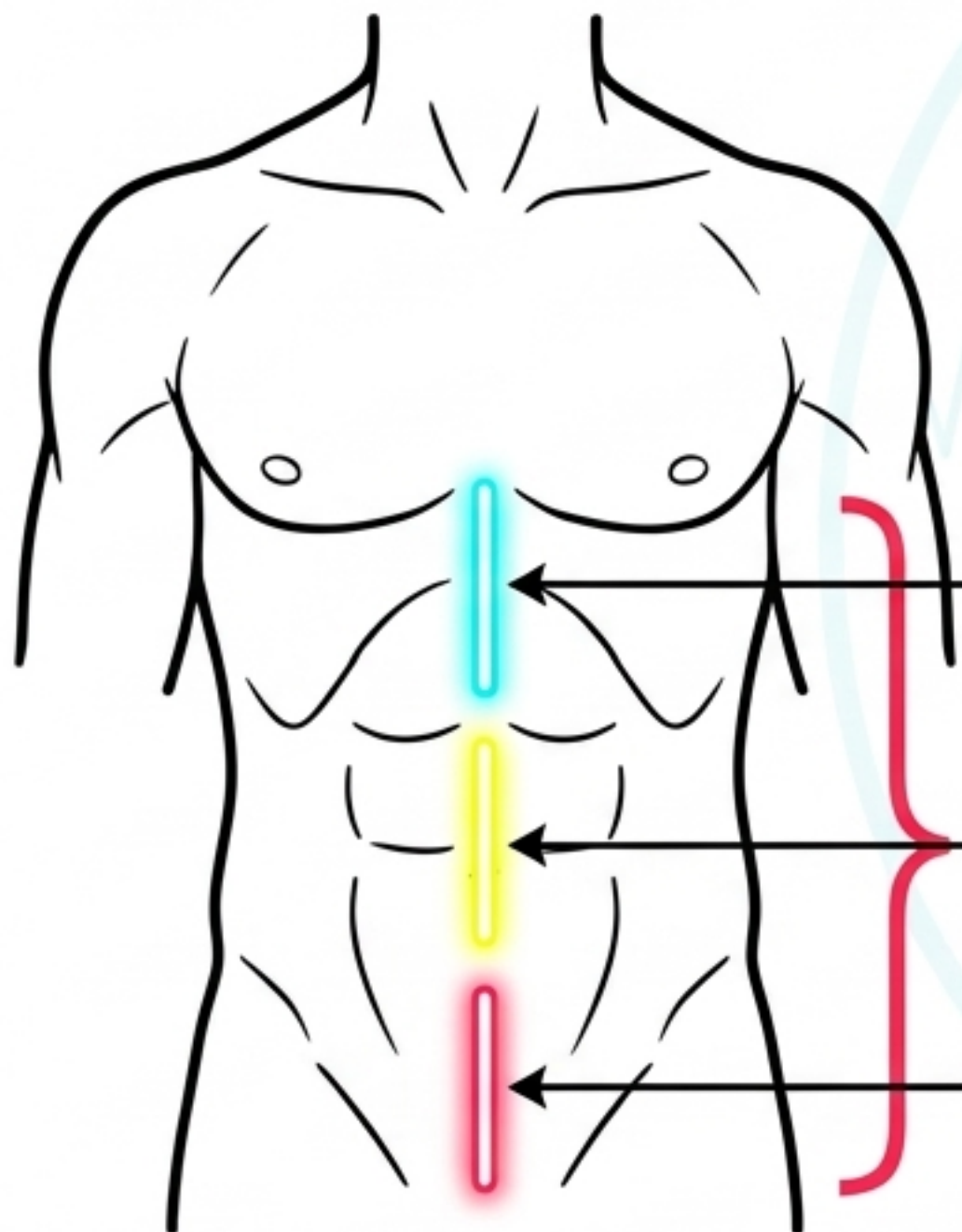
EL ABORDAJE QUIRÚRGICO: LA REGLA DE ORO

AXIOMA: El factor determinante definitivo es la Estabilidad Hemodinámica del paciente.



TOPOGRAFÍA DE LA LAPAROTOMÍA Y CONVERSIÓN

Anatomía



Mediana Supraumbilical:

Xifoides a ombligo. Acceso superior (Estómago, Duodeno, Vía Biliar).

Mediana Infraumbilical:

Ombligo a pubis. Acceso inferior (Pelvis, Colon, Apéndice atípico).

Mediana Xifopubiana:

Máxima exposición de extremo a extremo. Peritonitis difusa o sangrado de origen desconocido.

Alert



Criterios de Conversión (Laparoscopia → Abierta):

- Exposición visual insegura o anatomía hostil severa.
- Deterioro hemodinámico intraoperatorio súbito.
- Sangrado masivo incontrolable o necrosis extensa no abordable.
- Pérdida del neumoperitoneo o falla del instrumental.

CLASIFICACIÓN DE LA PERITONITIS E INFECCIÓN

Infección Complicada: El proceso supera el órgano de origen y contamina el peritoneo.
Requiere siempre Control del Foco Quirúrgico + Antibióticos.

PRIMARIA

- Sin perforación anatómica del tracto gastrointestinal.
- Monomicrobiana (ej. Bacteriana Espontánea en cirróticos).
- Manejo: Tratamiento médico exclusivo (No Quirúrgico).



SECUNDARIA (La Emergencia)

- Fuente intraabdominal anatómica identificable (perforación de víscera hueca, dehiscencia).
- Polimicrobiana (Gram negativos y Anaerobios).
- Manejo: CIRUGÍA URGENTE INMEDIATA para control de la fuente.

TERCIARIA

- Infección persistente o recurrente post-tratamiento de peritonitis secundaria.
- Frecuente en pacientes críticos (UCI).
- Microorganismos multirresistentes y oportunistas.



ESQUEMAS ANTIBIÓTICOS EMPÍRICOS (CONTROL DE DAÑOS)

Blancos Microbianos Clave: Gram Negativos (E. coli, Klebsiella) y **Anaerobios** (B. fragilis).

Comunidad (Bajo/Moderado Riesgo)

Pacientes sin exposición sanitaria reciente ni cirugías complejas.

- ✓ - Esquema Clásico: Ceftriaxona (2g IV/24h) + Metronidazol (500mg IV/8h).
- ✓ - Alternativa: Ertapenem (1g IV/24h) si existe sospecha de bacterias productoras de BLEE.

Intrahospitalaria / Críticos (Alto Riesgo)

Cobertura antipseudomónica obligatoria para estancias prolongadas.

- ✓ - Opción 1: Piperacilina/Tazobactam (4.5g IV/6h).
- ✓ - Opción 2: Meropenem (1g IV/8h) especialmente para shock séptico o multirresistencia.
- ✓ - Opción 3: Cefepime + Metronidazol.



ALERTA: NO incluir Vancomicina empírica rutinaria sin cultivo previo. Considerar Antifúngicos (Cándida) únicamente en portadores de catéteres venosos centrales o UCI prolongada.



EL PARADIGMA MODERNO: EL BISTURÍ ES EL MEJOR ANTIBIÓTICO

EL AXIOMA: Los antimicrobianos **NUNCA** reemplazan un drenaje adecuado. El Control del Foco Quirúrgico es la única cura real.

DÍA 0 (Cirugía / Control del Foco)

DÍA 2 (48h)

DÍA 4

Apendicitis Complicada controlada
(No-inferior a regímenes largos).

Límite Máximo con Control del Foco Exitoso.
Más antibiótico **NO** significa mejor tratamiento.

Regla de Falla: Si el paciente sigue febril al terminar el ciclo corto, **NO** prolongue los antibióticos a ciegas. Busque un absceso residual no drenado o una fuga anastomótica mediante reevaluación clínica y Tomografía Computarizada.

